MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Limitaciones y sesgos

Ningún estudio es perfecto, y una de las competencias más valiosas —y menos enseñadas— de un MSL excelente es la capacidad de identificar de forma sistemática las limitaciones y los sesgos de la evidencia que presenta, en lugar de comunicarla como si fuera una verdad absoluta. Esta honestidad metodológica es, precisamente, lo que separa la comunicación científica no promocional de la comunicación comercial.

- Identificar limitaciones y sesgos, en lugar de comunicar la evidencia como verdad absoluta
- La honestidad metodológica separa la comunicación científica de la comercial
- Una de las competencias más valiosas y menos enseñadas del MSL

Entre los sesgos más relevantes que un MSL debe saber identificar está el sesgo de selección, que ocurre cuando el proceso de reclutamiento o los criterios de inclusión/exclusión generan una muestra no representativa de la población real a la que se quiere aplicar el resultado —el problema clásico de la brecha entre eficacia (en el ensayo, con pacientes muy seleccionados) y efectividad (en la práctica real). El sesgo de confusión (confounding), especialmente relevante en estudios observacionales, ocurre cuando una tercera variable influye tanto en la exposición como en el resultado, generando una asociación aparente que no refleja una relación causal real; controlar la confusión mediante ajuste estadístico o emparejamiento por puntuación de propensión reduce, pero no elimina por completo, este riesgo. El sesgo de publicación describe la tendencia bien documentada de que los estudios con resultados positivos o estadísticamente significativos tienen más probabilidad de publicarse que los estudios con resultados neutros o negativos, distorsionando la evidencia disponible en la literatura hacia una imagen más favorable de lo que realmente ocurre. El sesgo de medición o de clasificación errónea ocurre cuando la exposición o el resultado se miden de forma imprecisa o inconsistente entre grupos.

Sesgos en la evidencia

→ **Sesgo de selección**
→ **Sesgo de confusión (confounding)**
→ **Sesgo de publicación**
→ **Sesgo de medición**

También es esencial que el MSL distinga entre significación estadística y relevancia clínica, un tema ya tratado en profundidad en la lección sobre p-valores, pero que aquí adquiere una dimensión adicional: un estudio puede tener limitaciones metodológicas sutiles —una tasa alta de abandonos diferencial entre brazos, un seguimiento demasiado corto para el resultado de interés, un análisis por protocolo en lugar de por

intención de tratar— que, sin invalidar el estudio, sí deben matizar la fuerza con la que se comunica su conclusión.

- Distinguir significación estadística de relevancia clínica
- Abandonos diferenciales, seguimiento corto o análisis por protocolo frente a por intención de tratar
- Estas limitaciones deben matizar la fuerza con la que se comunica la conclusión

La buena práctica internacional, reflejada en marcos como CONSORT para ensayos clínicos y STROBE para estudios observacionales, exige que toda publicación incluya una sección explícita de limitaciones. Un MSL riguroso debe leer siempre esa sección antes de presentar el estudio, no solo el resumen de resultados, porque ahí es donde los propios autores reconocen los límites de lo que su estudio puede afirmar.

- CONSORT (ensayos) y STROBE (observacionales) exigen una sección explícita de limitaciones
- El MSL riguroso debe leer esa sección, no solo el resumen de resultados
- Ahí los propios autores reconocen los límites de lo que el estudio puede afirmar

Comunicar las limitaciones de un estudio no debilita el mensaje científico del MSL: lo fortalece. Un HCP experimentado detecta rápidamente cuándo un interlocutor presenta solo los datos favorables y omite las limitaciones, y esa omisión —aunque no sea intencionada— daña la credibilidad de forma duradera. La transparencia sobre lo que la evidencia no puede afirmar es, en última instancia, la base sobre la que se construye la confianza científica a largo plazo entre Medical Affairs y la comunidad médica.

- Comunicar las limitaciones fortalece el mensaje científico, no lo debilita
- Un HCP experimentado detecta cuándo se omiten las limitaciones
- La transparencia es la base de la confianza científica a largo plazo